

Fecha Última Actualización: 22-10-2022 8:26:53

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Oscar Gabriel Herazo Silva
Edad : 53a 4m 25d
Dirección : Dr. Sotero Del Rio 3271

Rut : 11.606.553-3
Fecha Nacto: 27/05/1969
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1025240
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7918 9538

N° Epicrisis
306173

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto
Unidad de Egreso : Utim

Fecha Ingreso : 30/03/2022 03:32
Fecha Egreso : 22/10/2022 03:26

Días Estadía: 206

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor toracico

Comorbilidades

Hipertensión Arterial; Diabetes Mellitus 2;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR/UCO: 30/03/22
FI UCI: 13/05/22
FI UTIM: 11/10/22
FI SALA: 15/10/22
FI UTIM: 17/10/22

Anamnesis remota:

- atcd Mórbitos: HTA, DM2 NIR
- atcd Quirúrgicos: No refiere
- Fármacos: Desconocidos
- Alergias: No refiere
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones: No recientes

MC dolor torácico

Anamnesis próxima:

Paciente con antecedentes descritos, con historia de 4 días de sintomatología respiratoria alta a lo que se agrega DREO típico. Evaluado inicialmente en HPH donde se pesquisa ECG con QS y SDST en DII, DIII, aVF y V3-V6, sin compromiso derecho. Se administra AAS 500 mg, Clopidogrel 300 mg, Atorvastatina 80 mg, HNF 5000 UI. Se solicitan exámenes en los que destaca acidosis metabólica con AG aumentado, hiperglicemia y TUS elevada (909) por lo que se deriva a HSR para manejo de SCA c/SDST. Ingresa taquicárdico, con presiones límites, Spo2 88% con MNR a 15 L/min. Se describe vigil, OTE, cooperador, con llene capilar 3-4 segundos, en Killip III-IV, desaturando, con mala tolerancia al decúbito. Troponinas de control: 15.000

Se realiza ecocoscopia que evidencia akinesia de punta y pared anterior sin derrame pericárdico.

Se efectúa coronariografía de urgencia previo manejo de vía aérea, la que evidenció: ventriculografía con disfunción sistólica severa de VI, suboclusión aguda de ADA en 1/3 medio. Oclusión aguda distal de ACx. Oclusión crónica de ACD distal.

Se realizó angioplastia con stent a ADA y ACx. Posteriormente presentó deterioro hemodinámico y requerimientos de vasoactivos + inótrpos, en franco shock cardiogénico por lo que ingresa a UCO, posteriormente se traslada a UTIM, UPC, UTIM y SBM.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

Fecha Epicrisis : 22/10/2022 08:26

Página 1 de 4

Shock cardiogénico
- IAM c/SDST anterior e inferior
Cetoacidosis diabética
Antecedentes: HTA, DM NIR

EVOLUCIÓN UCO/UCI/UTIM/SBM

HDN/CV: Paciente ingresa cursando IAM c/SDST con shock cardiogénico, realizándose angioplastia el 30/03. Logra estabilidad HDN con suspensión de inótrópos a las 72h. Ecocardio TT formal 11/04 con FEVI de 34% y un trombo intraventricular apical, motivo por el cual se inicia anticoagulación. Presentó episodios de FA paroxística y flutter, autolimitados. Posteriormente evoluciona con múltiples intercorrientes infecciosas que condicionan uso de DVA de forma intermitente. Signos de ICC derecha (derrame pleural bilateral transudado) por lo que se inicia inótrópo asociado a espirolactona + iSGLT2 con terapia depleitiva. Nuevo ETT solicitado 11/10 y según resultado plan es evaluar con cardiología la suspensión de anticoagulación. En contexto de último hit infeccioso cursa con taquicardia, sin caída de hemodinamia.

Respiratorio: Múltiples intentos de weaning, con despertar agitado en contexto de fiebre y múltiples intercorrientes infecciosas. Se logra destetar del VMI de forma transitoria el 15/04 con falla precoz por vómitos y aspiración de contenido gástrico en contexto de sepsis de foco abdominal. 2 extubaciones fallidas (16/04 y 20/04) por lo que se realizó TQT percutánea sin incidentes el 25/04. Weaning dificultoso en relación a estado de conciencia y requerimientos de sedoanalgesia prolongada. Recibe clonidina + olanzapina + metadona con lo cual se obtiene una mejor respuesta y se logran ventanas de VMI a principios de junio 2022. Proceso además limitado por congestión importante que requirió manejo con UFA. 22/06 se realiza control de RxTx en la que se observa derrame pleural derecho masivo por lo que se instala tubo pleural, extrayendo 1400 cc de transudado. Cultivo negativo, 14/07 se logra retiro de pleurostomía. Posterior a eso dificultad en destetar de VM, paciente con episodios de angustia y disnea a pesar de buenos volúmenes y mecánica. Finalmente sin requerimientos de BiPAP desde el 02/10, iniciando rehabilitación con VF hasta 3 h. El 17/10 presenta deterioro en contexto de nuevo hit infeccioso, requiriendo conexión a BiPAP por mala mecánica, sin desaturación.

Infeccioso: Cursa con síndrome febril desde el 01/04/22 con múltiples esquemas antibióticos asumiendo foco respiratorio como lo más probable de forma inicial. Se escala de forma empírica a piperacilina/tazobactam + vancomicina dada gravedad de paciente. PCR Covid 02/04 negativa. Dada persistencia de fiebre a pesar de terapia se decide escalar a imipenem + vancomicina el día 03/04.

- 10/04 se agrega anidulafungina por candida en CAET y UC, suspendida precozmente dada baja sospecha de rol infeccioso.
- TAC TAP 16/05/22: colecistitis aguda gangrenosa. Colecistectomía laparoscópica de urgencia 16/05. TAC de control sin hallazgos sugerentes de complicación.
- 05/05 Suspende imipenem (completó 30 días), se cambia por Cetazidima + Linezolid dada Burkholderia cepacia en CAET + enterococo Van A y S epidermidis en cultivo de arrastre de CVC y Hc I para enterococo van A.
- 13/05 completa linezolid, pero dada elevación de PPII se cambia Ceftazidima por Meropenem (probable foco pulmonar).
- 17/05 presenta nuevo peak febril por lo que se pancultiva y se ajusta terapia a meropenem/ceftazidima, sugerido por infectología. Persistentemente Burkholderia cepacia + en CAET y CVC por lo que se mantiene ese esquema. Completa terapia y se solicita CAET de control que muestra nuevamente Burkholderia por lo que se decide reinicio de Meropenem. Completa 30 días en total, con mejoría clínica y de lab por lo que se decide suspensión a principios de junio.
- Nuevamente con elevación de PCR y CAET + CVC con Burkholderia, se evalúa con infectología y se decide iniciar meropenem + cotrimoxazol con buena respuesta clínica.
- PCR sostenidamente elevada sobre 100, se rescata CAET + para Klebsiella pneumoniae MS / Candida albicans, OC inflamatoria con UC negativo y HC + Staphylococcus haemolyticus MR. Se decide iniciar ampi/sulbactam y se interpreta HC como contaminación. Completa 7 días de ampi/sulbactam.
- A finales de julio nuevamente CAET + B cepacia y KPN por lo que, evaluado por infecto, se decide nuevamente inicio de meropenem.

Paciente con múltiples peaks febriles terminado el tto con aislamiento de Burkholderia cepacia en CAET y HC, tratados múltiples veces con carbapenémicos y otras con cotrimoxazol.

- A fines de agosto se agrega acinetobacter baumannii + KPN MS al CAET por lo que se asocia colistin.
- Evaluado por infectología a fines de septiembre se decide tratamiento con tigeciclina por 7 días y luego control con CAET. Se rescata también en cultivos del 27/09 un Acinetobacter baumannii por lo que se decide agregar Ceftazidima/Avibactam.
- CAET del 04/10 positivo a Burkholderia/ACBA/calcoaceticus complex. Definido por infectología se maneja con 7 días de tigeciclina y completar 14 días con cefta/avi (hasta el 15/10) + 10 días colistin NBZ (hasta 19/10).
- 11/10 en CAET nuevamente (+) Burkholderia (300k UFC) y Candida albicans (60k UFC), asociado a secreción purulenta

Fecha Última Actualización: 22-10-2022 8:26:53

Página 3 de 4

verdosa y aumento PPII, por lo que se indica cobertura de candida con anidulofungina.

- 17/10 nuevo deterioro ventilatorio + fiebre por lo que se pancultiva y se retira PICC de 17 días, mandando punta a cultivo. Según lo discutido con infectología se inicia manejo empírico con ceftazidima/avibactam + colistin + linezolid.

Renal: AKI multifactorial, que llega a requerir TRR, última en abril 2022. 17/05 en relación a hit infeccioso presenta falla renal reagudizada asociado a congestión pulmonar persistente por lo que se instala nuevo catéter de diálisis, dializándose para optimizar BH negativos. Evoluciona con normalización de función renal y recuperación de diuresis, sin TRR del 23/06. Alteraciones hidroelectrolíticas en relación a uso de cotrimoxazol, ya resueltas.

Dermatológico: Presenta lesión dérmica en pie izquierdo, que evolucionó rápidamente como escara. Se sospecha un pioderma gangrenoso. Biopsia por dermatología con resultado pendiente. Además, UPP sacra y maleolar en curaciones.

Nutrición: Inicialmente con SNG, luego SNY y posteriormente NPTC por pérdida ponderal y baja tolerancias a nutrición enteral. Posteriormente se realiza GGT y evoluciona con GTT disfuncional, se realiza EDA 14/10 con reinstalación de GGT, pero evoluciona con alimentación en porción subglótica de TQT por lo que se suspende y se reinicia en forma lenta y progresiva. Evaluado por ANI, con indicación de llegar a 48 cc/h de su fórmula.

Desde quiebre clínico marcado del 17-10 evoluciona en malas condiciones generales. Se mantuvo recibiendo soporte hemodinámico con noradrenalina a dosis media, milrinona a dosis plena; soporte respiratorio con VMi por TQT en modo controlado y con sedoanalgesia para SAS1 y recibiendo antibioterapia ajustada a función renal y acorde con microbiología previa (Colistin, Ceftazidima/Avibactam, Linezolid (FI 17/10) y Anidulafungina (FI 14/10)). Evoluciona con falla multiorgánica marcada por falla renal anúrica, respiratoria, cardíaca y coagulopatía que no corrige tras administración de 6 UI PFC.

Dada evolución desfavorable se acuerda con la familia acompañamiento familiar.

Paciente fallece a las 03:26 am

Diagnósticos de egreso

Falla orgánica múltiple

- Obs Candidemia ITU CUP Candiduria + Traqueitis por Burkholderia / Candida albicans
- Shock séptico y cardiogénico
- Injuria renal aguda oligoanúrica multifactorial
- Obs CID secundaria. Anemia severa sintomática, sangrado gingival
- Insuficiencia respiratoria global - Acidosis metabólica AG normal
- polineuropatía del paciente crítico - TQT 24-05
- Traqueitis vs NAVM (CAET 04/10 (+) Burkholderia/ACBA/calcoaceticus complex) tratada
- Disfagia severa - GTT 14-10
- LPP sacra y maleolar

Tratadas

- NAVM recurrente por Burkholderia Cepacia complex
- ITS (E faecium van A en arrastre CVC)
- Colecistitis aguda gangrenosa resuelta - Colecistectomía laparoscópica (16/04)
- IAM c/SDST Killip IV - PCI ADA y ACx. OC ACD
- Disfx VI severa - FEVI 34% - PFDVI 38 mmHg - Obs. Trombo IV
- Diabetes Mellitus 2, Hipertensión arterial

Diagnóstico de Egreso

Choque Cardiogenico -
neumonía asociada a VM -
Falla orgánica múltiple -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fecha Epicrisis : 22/10/2022 08:26

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:15

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Plan Post Alta

fallece a las 03:26

Indicaciones

Tipo de Reposo : Semisentado 45°

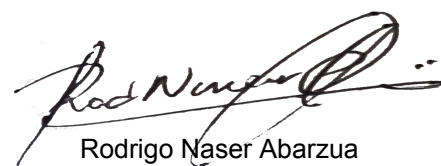
Régimen Alimentario : Nutrición Enteral

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Rodrigo Naser Abarzua

Médico Tratante (Staff)